Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Spécialiste en oto-rhino-laryngologie et chirurgie cervico-faciale

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

FORMULAIRE DE CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ

Adénoïdectomie

Ablation des végétations adénoïdes

Chère patiente, cher patient, ce formulaire a été conçu pour vous expliquer, dans un **langage simple et clair**, ce que vous devez savoir sur l'intervention qui vous est proposée. Son objectif n'est pas de vous effrayer, mais de vous aider à prendre votre décision **librement et en connaissance de cause**.

Veuillez lire ce formulaire sans vous presser. Interrogez votre médecin sur tout ce que vous ne comprenez pas. Votre médecin vous expliquera également oralement les risques propres à votre situation. Donner ou non votre consentement est entièrement votre droit.

INFORMATIONS SUR LE PATIENT ET L'INTERVENTION

Nom et prénom : _____ Date de naissance : _____

N° de passeport / pièce d'identité : _____ N° de dossier / protocole : _____

Téléphone : _____ Date de l'information : _____

Date prévue de l'intervention : _____

Formulaire remis pour la première fois au patient (date / e-mail, WhatsApp, en main propre) : _____

Médecin réalisant l'intervention et délivrant l'information: **Op. Dr. Murat Ayata**

Établissement de santé où sera réalisée l'intervention : _____

Actes supplémentaires au cours de la même intervention : ☐ Amygdalectomie ☐ Aérateur(s) transtympanique(s) (yoyo) ☐ Aucun _____

Indication de l'opération (à remplir par le médecin) : ☐ Obstruction nasale / ronflement / apnée du sommeil ☐ Otite séromuqueuse / otites à répétition ☐ Adénoïdites / sinusites à répétition _____

Autre / remarques : _____

1 Votre état de santé et le but de l'intervention

Les végétations adénoïdes sont un tissu lymphoïde, appartenant au système de défense de l'organisme, situé à l'arrière du nez, au-dessus du palais. Elles peuvent augmenter de volume, en particulier chez les enfants de 2 à 7 ans, et diminuent généralement à partir de l'adolescence.

Des végétations hypertrophiées peuvent obstruer l'arrière du nez et entraîner **une respiration par la bouche, des ronflements, des pauses respiratoires pendant le sommeil, un nez qui coule, une voix nasonnée et des infections fréquentes**. Comme elles peuvent aussi obstruer l'orifice de la trompe d'Eustache, qui relie l'oreille à l'arrière du nez, elles peuvent entraîner **une accumulation de liquide dans l'oreille moyenne (otite séromuqueuse), une baisse de l'audition et des otites à répétition**. Une respiration buccale prolongée peut également affecter le développement du visage et des dents.

Le but de l'adénoïdectomie est de retirer les végétations hypertrophiées afin de faciliter la respiration par le nez et de réduire les problèmes d'oreilles, de sinus et des voies respiratoires. Votre médecin vous expliquera séparément pourquoi cette opération est recommandée pour vous ou votre enfant.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 Comment se déroule l'intervention ?

L'opération est réalisée sous anesthésie générale, au bloc opératoire. Elle se fait par la bouche ; **il n'y a aucune incision ni cicatrice à l'extérieur.**

1. **Préparation :** Une fois l'anesthésie réalisée, un instrument spécial est mis en place pour maintenir la bouche ouverte, et le voile du palais est délicatement soulevé afin de voir l'arrière du nez.
2. **Ablation des végétations :** Les végétations sont retirées de l'arrière du nez à l'aide d'une curette (instrument spécial de raclage), d'un microdébrideur guidé par endoscope, de la coblation ou de la diathermie (électrocoagulation). Les végétations étant un tissu et non un organe à part entière, elles ne peuvent pas être retirées « à la racine » ; le but est de retirer en toute sécurité la partie responsable de l'obstruction.
3. **Contrôle du saignement :** Une compression est appliquée brièvement sur la zone à l'aide d'une compresse et, si nécessaire, le saignement est arrêté par électrocoagulation. Aucune mèche n'est laissée à l'arrière du nez à la fin de l'opération.
4. **Actes supplémentaires :** S'ils sont prévus, l'ablation des amygdales (amygdalectomie) ou la pose d'aérateurs transtympaniques dans les tympans sont réalisées sous la même anesthésie. Des formulaires de consentement distincts sont remplis pour ces actes.
5. **Réveil :** Après l'opération, le patient est étroitement surveillé en salle de réveil jusqu'à son réveil complet.

Si le médecin le juge nécessaire, le tissu retiré est envoyé pour examen anatomopathologique.

ANESTHÉSIE	DURÉE APPROXIMATIVE	HOSPITALISATION / SORTIE
Anesthésie générale	Environ 20–30 minutes (hors temps d'anesthésie)	Généralement retour à domicile le jour même ; une nuit de surveillance si nécessaire

3 Bénéfices attendus et chances de succès

- Une respiration nasale plus facile, avec moins de ronflements et moins de pauses respiratoires pendant le sommeil
- Un sommeil de meilleure qualité, et donc une amélioration de l'attention, du comportement et des résultats scolaires pendant la journée
- Moins d'épisodes de liquide dans l'oreille moyenne et d'otites, ce qui contribue à améliorer l'audition
- Moins d'écoulement nasal, et moins d'épisodes de sinusite et d'infections des voies respiratoires supérieures

Chez des patients soigneusement sélectionnés, l'obstruction nasale et les ronflements s'améliorent nettement dans la grande majorité des cas. Cependant, si l'obstruction a aussi d'autres causes — comme une allergie, des cornets hypertrophiés ou une déviation de la cloison —, les symptômes peuvent ne pas disparaître complètement. Le succès pour les problèmes d'oreilles dépend aussi du développement de la trompe d'Eustache ; certains enfants peuvent avoir besoin d'un traitement complémentaire ou d'aérateurs transtympaniques.

4 Autres options thérapeutiques

- **Surveillance :** Si les symptômes sont légers, il est possible d'attendre avec des contrôles réguliers, car les végétations diminuent avec l'âge.
- **Médicaments :** Les sprays nasaux à base de corticoïdes peuvent réduire temporairement le volume des végétations et l'obstruction chez certains enfants ; en cas d'allergie, celle-ci est traitée. L'effet ne dure généralement que le temps de la prise du médicament.
- **Aérateurs transtympaniques seuls pour les problèmes d'oreilles :** Dans certains cas, la pose d'aérateurs dans les tympans sans ablation des végétations peut être envisagée.
- **Autres options pour l'apnée du sommeil :** Dans de très rares cas où la chirurgie n'est pas adaptée, un appareil de ventilation en pression positive continue (PPC) peut être utilisé pendant le sommeil.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

5 Que se passe-t-il si l'intervention n'est pas réalisée ?

Si l'opération n'est pas réalisée, les végétations peuvent diminuer d'elles-mêmes à l'adolescence. D'ici là, cependant, la respiration par la bouche, les ronflements, un sommeil de mauvaise qualité, les infections à répétition et la baisse d'audition due au liquide dans l'oreille peuvent persister. Des troubles respiratoires du sommeil anciens et sévères peuvent, chez l'enfant, entraîner un retard de croissance et de développement, des troubles de l'attention et du comportement et, rarement, une surcharge pour le cœur et les poumons. Un liquide persistant longtemps dans l'oreille moyenne peut affecter le développement du langage et provoquer des modifications définitives du tympan.

Vous avez le droit de refuser l'intervention proposée, de la reporter ou de demander l'avis d'un autre médecin. Cette décision n'aura aucune incidence sur les autres soins qui vous sont proposés. Vous pouvez retirer votre consentement à tout moment avant le début de l'intervention ; sachez toutefois qu'une fois l'intervention commencée, il peut exister des étapes auxquelles l'interrompre serait médicalement risqué.

6 Préparation à l'intervention

- Des analyses de sang (en particulier des tests de saignement et de coagulation) et tout autre examen nécessaire sont réalisés avant l'opération, et vous serez examiné(e) par le médecin anesthésiste.
- Merci de nous signaler s'il existe dans la famille des antécédents de saignements faciles, d'ecchymoses ou de trouble de la coagulation.
- Aucun aliment solide ni lait ne doit être donné pendant les **6 heures** précédant l'opération ; pour les liquides clairs, respectez le délai indiqué par le médecin anesthésiste.
- Merci de nous signaler toute fièvre, diarrhée, toux ou grippe survenue dans les 2–3 semaines précédant l'opération ; il peut être nécessaire de la reporter.
- Si une dent de lait bouge, dites-le à votre médecin, car elle pourrait tomber pendant l'anesthésie.
- Nous vous recommandons de préparer votre enfant à l'opération avec des mots adaptés à son âge et qui ne lui font pas peur.
- Informez votre médecin de **tous les médicaments** que vous prenez (y compris les médicaments qui fluidifient le sang, l'aspirine, les antalgiques, les médicaments amaigrissants et hormonaux) ainsi que des **produits à base de plantes et compléments alimentaires** (oméga-3, vitamine E, ginkgo, ail, ginseng, huile de poisson, etc.). N'arrêtez aucun médicament de vous-même sans l'avis de votre médecin.
- Signalez-nous impérativement vos **allergies**, tout problème de saignement ou de coagulation, toute maladie cardiaque ou pulmonaire, un diabète, une hypertension artérielle ou une maladie de la thyroïde, vos opérations antérieures et tout problème rencontré lors d'une anesthésie.
- S'il existe une possibilité que vous soyez enceinte, ou si vous allaitez, dites-le-nous avant l'intervention.
- Le tabac et les produits à base de nicotine altèrent nettement la cicatrisation. Si possible, arrêtez au moins 2–4 semaines avant l'intervention et ne fumez pas pendant la convalescence.

7 Convalescence : à quoi vous attendre

Jour de l'opération	Au réveil, il peut y avoir un léger mal de gorge, des sécrétions nasales teintées de sang et une respiration par la bouche. Des vomissements ou une légère fièvre peuvent survenir. Une fois les éventuelles nausées passées, on donne d'abord de l'eau, puis des aliments tièdes et mous. La plupart des patients rentrent chez eux le jour même.
3–5 premiers jours	L'obstruction nasale et les ronflements peuvent encore être présents en raison du gonflement ; une mauvaise haleine, une légère fièvre, des douleurs d'oreille et des douleurs du cou peuvent survenir. La douleur est généralement légère et soulagée par les antalgiques recommandés par votre médecin. Il est important de boire beaucoup.
1re semaine	La plupart des enfants peuvent retourner à l'école ou à la crèche en 3–7 jours, et les adultes au travail. Évitez les lieux très fréquentés et les personnes malades pendant la première semaine.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2e–4e semaine	À mesure que le gonflement diminue, la respiration nasale s'améliore nettement. Une éventuelle voix nasonnée temporaire disparaît généralement durant cette période. La natation et les sports intenses sont généralement autorisés après 2 semaines.
1er–3e mois	Un examen de contrôle est réalisé ; si l'opération a été faite pour des problèmes d'oreilles, un test auditif et une tympanométrie permettent de contrôler les oreilles.

8 Risques et complications possibles

Comme tout acte médical, cette intervention comporte certains risques. Ci-dessous, les **effets temporaires attendus** et les **complications** sont présentés séparément et regroupés selon leur fréquence. Les chiffres indiqués sont des valeurs **approximatives** issues de la littérature médicale ; votre risque personnel peut être plus faible ou plus élevé selon votre âge, votre état de santé général, votre tabagisme et vos opérations antérieures.

La grande majorité des complications sont **temporaires** et s'améliorent avec un traitement adapté. Des événements très rares mais graves sont également mentionnés ; leur présence dans cette liste ne signifie pas qu'ils vous arriveront, mais vous devez les connaître pour prendre une décision éclairée.

Effets temporaires attendus (ce ne sont pas des complications — ils font normalement partie de la guérison)

- Léger mal de gorge et gêne à la déglutition
- Sécrétions nasales teintées de sang et obstruction nasale pendant quelques jours
- Mauvaise haleine (due à la surface en cours de cicatrisation ; disparaît en 1–2 semaines)
- Douleur d'oreille (douleur projetée par des nerfs communs ; elle ne signifie pas qu'il y a un problème dans l'oreille)
- Légère fièvre (les 1–2 premiers jours), nausées et vomissements dus à l'anesthésie

Situations fréquentes (la plupart sont temporaires ou disparaissent avec un traitement)

- **Voix nasonnée temporaire** — Après l'ablation des végétations, le voile du palais a besoin de temps pour s'adapter ; de l'air peut s'échapper par le nez lors de la parole pendant quelques jours à quelques semaines et, occasionnellement, des liquides peuvent refluer par le nez. Cela disparaît généralement de soi-même en 1–2 mois.
- **Douleur et raideur du cou** — En raison de la position opératoire et de la cicatrisation à l'arrière du nez, les mouvements du cou peuvent être douloureux les premiers jours ; cela disparaît généralement en quelques jours.
- **Symptômes ne disparaissant pas complètement** — En présence de causes supplémentaires comme une allergie, des cornets hypertrophiés ou une déviation de la cloison, l'obstruction nasale peut persister en partie ; un traitement complémentaire peut être nécessaire.

Situations peu fréquentes

- **Saignement** — Un saignement important après l'opération survient chez **moins de 1 patient sur 100 (environ 0,5–1 sur 100)**. Il survient le plus souvent dans les 24 premières heures. Si le saignement ne peut pas être arrêté, **un retour au bloc opératoire sous anesthésie générale pour l'arrêter** peut être nécessaire. Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire.
- **Lésion dentaire** — La pression de l'instrument utilisé pour maintenir la bouche ouverte peut ébrécher ou déloger une dent, en particulier une dent qui bouge déjà ou qui est cariée.
- **Blessure ou gonflement des lèvres, de la langue ou du palais** — De petites plaies ou un gonflement temporaire peuvent survenir au contact des instruments ; ils guérissent en quelques jours.
- **Infection** — Peut se manifester par une montée de la fièvre, une aggravation de la mauvaise haleine et une augmentation de la douleur ; elle s'améliore généralement sous antibiotiques.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Repousse des végétations** — Le tissu adénoïdien peut repousser (chez environ **1–5 patients sur 100**), en particulier chez les enfants opérés très jeunes et chez les personnes allergiques. Si les symptômes réapparaissent, une nouvelle opération peut rarement être nécessaire.

Situations rares ou très rares, mais potentiellement graves

- **Voix nasonnée définitive / reflux de liquides par le nez (insuffisance vélopharyngée)** — Survient chez environ **1 patient sur 1 500–3 000** ; le risque est plus élevé chez les enfants ayant une fente palatine cachée (fente sous-muqueuse). Elle s'améliore généralement avec une rééducation orthophonique ; rarement, une opération de correction peut être nécessaire. C'est pourquoi le palais est examiné avec attention avant l'opération.
- **Glissement des vertèbres cervicales (syndrome de Grisel)** — Affection **très rare** dans laquelle l'inflammation à l'arrière du nez atteint les ligaments des vertèbres cervicales supérieures. Elle se manifeste par une douleur du cou qui commence dans les jours suivant l'opération et s'aggrave progressivement, une impossibilité de tourner la tête et une tête maintenue inclinée d'un côté. Si elle est reconnue tôt, elle est traitée par des médicaments et un collier cervical ; si le diagnostic est retardé, un traitement plus long ou, rarement, une chirurgie peuvent être nécessaires, et une limitation définitive des mouvements du cou peut persister. Une douleur du cou qui s'aggrave progressivement doit donc toujours être signalée.
- **Adhérences ou rétrécissement à l'arrière du nez** — Très rarement, en particulier lorsqu'une grande quantité de tissu est retirée en même temps qu'une amygdalectomie, un rétrécissement peut apparaître à l'arrière du nez au cours de la cicatrisation ; il peut provoquer une obstruction nasale et nécessiter un traitement complémentaire.
- **Saignement grave et ses conséquences** — De manière extrêmement rare, en présence d'un vaisseau sanguin au trajet anormal ou d'un trouble de la coagulation méconnu, un saignement grave peut survenir. Une chirurgie d'urgence, une transfusion sanguine et une prise en charge en **réanimation** peuvent alors être nécessaires ; le passage de sang dans les voies respiratoires peut entraîner des problèmes respiratoires.

Risques généraux propres à toute intervention chirurgicale / médicale

- **Risques liés à l'anesthésie :** Si une anesthésie générale ou une sédation est utilisée, ses risques (nausées, maux de gorge, lésion dentaire, réaction allergique et, très rarement, problèmes cardiaques ou pulmonaires) vous seront expliqués séparément par le médecin anesthésiste, et votre consentement sera recueilli sur un **formulaire de consentement à l'anesthésie distinct**.
- **Saignement et transfusion sanguine :** Le recours à une transfusion sanguine est très rare dans ces interventions. En cas de saignement important, du sang ou des produits sanguins peuvent être nécessaires ; ils comportent leurs propres risques, très rares (allergie ou infection, par exemple).
- **Infection :** Une infection de la plaie après l'opération est généralement traitée par antibiotiques ; rarement, un drainage (évacuation du pus) peut être nécessaire.
- **Caillots de sang dans les veines des jambes (thrombose veineuse profonde, TVP) et dans les poumons (embolie pulmonaire) :** Très rares lors des interventions courtes de la tête et du cou. Se lever et marcher tôt réduit le risque. Les traitements hormonaux, le tabac, l'obésité et des antécédents de caillots augmentent le risque.
- **Allergie médicamenteuse :** Une réaction allergique peut survenir aux médicaments, antiseptiques, sparadraps ou fils de suture utilisés.
- **Cicatrices et troubles de la cicatrisation :** L'aspect des cicatrices varie d'une personne à l'autre ; très rarement, une cicatrice épaisse (hypertrophique) ou une chéloïde peut se former.
- **Risque vital :** Le décès lors d'une chirurgie programmée de la tête et du cou est aujourd'hui extrêmement rare ; cependant, aucune intervention chirurgicale n'est totalement dénuée de risque. Une complication grave peut nécessiter une prise en charge en réanimation et entraîner un handicap permanent.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Cette liste ne comprend pas toutes les complications possibles ; d'autres événements imprévisibles et très rares peuvent survenir. Si une complication apparaît, votre médecin planifiera le traitement et le suivi nécessaires ; cela peut nécessiter un traitement supplémentaire, des médicaments, des actes complémentaires ou une nouvelle opération.

9 Quand nous contacter immédiatement

- **Sang frais, rouge** par la bouche ou le nez, crachats ou vomissements de sang (tout saignement au-delà de quelques gouttes doit être signalé)
- Déglutitions fréquentes (chez l'enfant, signe important que du sang est avalé), pâleur, grande fatigue
- **Fièvre supérieure à 38,5 °C**, ou fièvre qui ne baisse pas avec les antalgiques
- Refus total de boire, absence d'urines depuis 6–8 heures, somnolence inhabituelle (signes de déshydratation)
- **Douleur du cou** qui s'aggrave progressivement, impossibilité de tourner la tête ou tête maintenue inclinée d'un côté
- Difficultés respiratoires ou pauses respiratoires marquées pendant le sommeil

Si l'un de ces signes apparaît, appelez votre médecin sans attendre : +90 288 502 50 20 · WhatsApp +90 555 333 21 20. Si vous ne parvenez pas à nous joindre, rendez-vous au service d'urgences le plus proche ou appelez le 112 (numéro d'urgence en Turquie et dans toute l'Europe).

10 Conseils concernant les médicaments et la vie quotidienne

- Contre la douleur, utilisez uniquement **les antalgiques recommandés par votre médecin** ; l'aspirine et les médicaments contenant de l'aspirine ne doivent pas être utilisés, car ils peuvent augmenter le saignement.
- Les premiers jours, des aliments mous tièdes ou frais et **beaucoup de liquides** sont recommandés ; évitez les aliments très chauds, durs et épicés.
- Ne vous mouchez pas fort pendant la première semaine.
- Si un vol de retour à l'étranger est prévu au cours de la première semaine après l'opération, discutez avec votre médecin du moment le plus précoce auquel il est sûr de prendre l'avion ; en raison du risque de saignement, il est conseillé de rester à proximité de votre médecin pendant les premiers jours.
- Prenez les médicaments qui vous ont été prescrits (antibiotiques, antalgiques, etc.) à la dose et pendant la durée recommandées. Ne prenez pas d'aspirine ni de médicaments similaires susceptibles d'augmenter le saignement sans avoir consulté votre médecin.
- Lors d'un vol ou d'un trajet de plus de 4 heures après l'opération, buvez beaucoup d'eau, bougez régulièrement et portez des bas de contention si cela vous a été conseillé ; cela réduit le risque de caillots dans les jambes.
- Pendant la convalescence, il est conseillé de ne pas boire d'alcool et d'éviter le tabac et les produits à base de nicotine.
- Veuillez vous présenter à tous les rendez-vous de suivi. Si vous êtes venu(e) de l'étranger, le suivi après votre retour peut se poursuivre par consultation en ligne et photos/vidéos ; si vous devez consulter un médecin sur place, un compte rendu opératoire écrit et nos recommandations vous seront remis.

11 Situations imprévues pendant l'intervention, prélèvements de tissus et produits sanguins

Si une situation imprévue survient pendant l'intervention, votre médecin restera dans le cadre de l'intervention à laquelle vous avez consenti dans ce formulaire. **Sauf en cas de danger vital ou de risque d'atteinte grave d'un organe**, aucun acte supplémentaire auquel vous n'avez pas consenti ne sera réalisé ; dans ce cas, l'intervention sera terminée à un stade sûr et vous serez informé(e) ensuite afin que la décision soit prise avec vous. Si votre vie est en danger, les soins d'urgence nécessaires pour protéger votre vie ou l'organe seront réalisés.

Les tissus retirés pendant l'intervention seront, si nécessaire, envoyés pour **examen anatomopathologique** afin de confirmer le diagnostic. Selon le résultat, un traitement ou un suivi complémentaire peut être nécessaire.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Une transfusion sanguine est très rarement nécessaire dans ces interventions et ne sera réalisée qu'en cas de nécessité vitale. Si vous n'acceptez pas le sang ou les produits sanguins (par exemple pour des raisons religieuses), vous devez nous le signaler avant l'intervention ; les conséquences possibles de cette décision seront discutées séparément avec vous et consignées dans la rubrique « Informations vous concernant personnellement ».

12 Photographies, enregistrements d'images et vos données personnelles

Des **photographies/vidéos** peuvent être réalisées avant et après l'intervention pour la planification, le suivi et l'évaluation du résultat. Ces enregistrements font partie de votre dossier médical et restent confidentiels. Vos images ne seront **jamais utilisées à des fins publicitaires, promotionnelles ou sur les réseaux sociaux.**

Vos images ne peuvent être utilisées à d'autres fins **qu'avec votre autorisation distincte et explicite**. Un refus n'aura aucune incidence sur votre traitement, et vous pouvez retirer votre autorisation à tout moment :

- ☐ J'accepte que mes images soient utilisées **uniquement pour le dossier médical et le suivi du traitement**.
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui ne permet pas de m'identifier** (visage/zone des yeux masqués).
- ☐ J'autorise l'utilisation de mes images pour des publications scientifiques et l'enseignement médical **d'une manière qui peut permettre de m'identifier**.
- ☐ Je **n'autorise pas** l'utilisation à des fins scientifiques/pédagogiques.

Vos données personnelles et de santé sont traitées conformément à la loi turque n° 6698 relative à la protection des données personnelles (KVKK) et à la législation sanitaire applicable, à des fins de diagnostic, de traitement et d'obligations légales, par des personnes soumises au secret professionnel. Pour plus de détails, vous pouvez consulter notre notice d'information sur la protection des données.

13 Informations et remarques vous concernant personnellement (à remplir par le médecin)

Risques supplémentaires propres au patient (maladies associées, médicaments, opérations antérieures), détails du plan, attentes du patient, questions posées et réponses apportées. S'il n'y a rien à ajouter, inscrire « néant ».

14 Déclaration du patient

- ☐ J'ai lu et compris ce formulaire dans ma langue. On m'a laissé suffisamment de temps de réflexion ; j'ai eu la possibilité de poser des questions et j'ai reçu des réponses satisfaisantes.
- ☐ Mon état de santé, le but de l'intervention proposée, la manière dont elle sera réalisée, par qui et où, sa durée approximative, les bénéfices attendus, les chances de succès, les alternatives et ce qui peut se passer si elle n'est pas réalisée m'ont été expliqués oralement et par écrit.
- ☐ Les risques fréquents et potentiellement graves, ainsi que les conséquences possibles de ces complications (y compris la nécessité éventuelle d'un traitement complémentaire ou d'une nouvelle intervention/opération), m'ont été expliqués. Je comprends que le résultat d'aucun acte médical **ne peut être garanti à 100 %**.
- ☐ J'ai fourni des informations exactes et complètes sur mon état de santé, les médicaments que je prends, mes allergies et mes maladies antérieures. Je comprends que des informations incomplètes ou inexactes peuvent augmenter les risques.
- ☐ Je comprends que le respect des consignes données avant et après l'intervention contribue au résultat et qu'il est important de me présenter aux rendez-vous de suivi.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- ☐ Je sais que je peux retirer mon consentement à tout moment avant le début de l'intervention. Je comprends que la signature de ce formulaire ne décharge pas le médecin de son devoir de prudence et de diligence.
- ☐ Je prends cette décision de mon plein gré, sans aucune pression de quiconque.
- ☐ On m'a expliqué que, pendant les premiers jours suivant l'opération, en particulier pour mon enfant, je dois surveiller les signes de saignement (déglutitions fréquentes, crachats ou vomissements de sang) et contacter le médecin.

- ☐ **Je DONNE MON CONSENTEMENT à l'intervention décrite ci-dessus.**
- ☐ **Je N'ACCEPTE PAS l'intervention décrite ci-dessus. Les conséquences possibles d'un refus m'ont été expliquées.**

Nous recommandons au patient d'écrire de sa propre main : « J'ai lu et compris ce formulaire et je donne mon consentement. »

15 Signatures

	NOM ET PRÉNOM	SIGNATURE	DATE / HEURE
Patient			
Représentant légal (parent / tuteur) — lien de parenté :			
Médecin délivrant l'information et réalisant l'intervention			
Interprète (si nécessaire) — langue :			
Témoin (si nécessaire)			

Déclaration de l'interprète : J'ai traduit intégralement et fidèlement ce formulaire ainsi que les explications orales du médecin au patient / représentant légal, dans une langue qu'il comprend.

POUR LES PATIENTS DE MOINS DE 18 ANS OU DONT LA CAPACITÉ DE DÉCISION EST LIMITÉE

Pour les patients de moins de 18 ans, le consentement est donné par un **parent ou le tuteur légal**. L'enfant est informé de manière adaptée à son âge et à sa maturité, et son avis est recherché. Pour les patients dont la capacité juridique est limitée, le consentement est donné par le représentant légal.

- ☐ Si nous exerçons conjointement l'autorité parentale, je déclare que l'autre parent est informé de cette intervention et y consent.
- ☐ Je déclare qu'il n'existe aucune décision de justice ni aucun litige concernant l'autorité parentale / la tutelle (le cas échéant, le document correspondant a été présenté au médecin).

L'enfant a été informé de manière adaptée à son âge ; avis de l'enfant : _____

Ce formulaire est établi en deux exemplaires : l'un est conservé dans le dossier du patient, l'autre est remis au patient / représentant légal.

Cabinet médical privé Op. Dr. Murat Ayata
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez, Kırklareli, Turquie
Tél.: +90 288 502 50 20 · WhatsApp: +90 555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

RETRAIT DU CONSENTEMENT (À REMPLIR UNIQUEMENT SI VOUS CHANGEZ D'AVIS)

Je retire le consentement que j'ai donné ci-dessus. Les conséquences possibles de ce retrait m'ont été expliquées.

Nom, signature, date et heure du patient / représentant qui retire son consentement : _____

Ce formulaire a été établi conformément au Règlement turc sur les droits des patients et aux principes de l'Association médicale turque en matière de consentement éclairé. Il complète, sans la remplacer, l'information orale donnée par votre médecin.